

Fecha Última Actualización: 29-04-2022 10:47:38

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Ricardo Enrique Cid Aedo

Rut : 9.377.445-0

N° Archivo : 0329311

N° Epicrisis

301886

Edad : 64a 9m 12d

Fecha Nacto: 17/07/1957

Sexo : Masculino

Dirección : Av. La Serena 2585 Pb. Los Canales

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 5192 0263

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 03/03/2022 20:29

Días Estadía: 57

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 29/04/2022 10:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre : Ricardo Enrique Cid Aedo

Edad : 64 años

RUT : 9377445-0

FI HSR: 03-03-22

FI UPC: 03-03-22

FI UTIM: 04-04-22

FI UPC: 09-04-22

FI UTIM: 18-04-22

FI Sala: 20-04-22

Anamnesis remota:

Antecedentes mórbidos: Gonartrosis bilateral

Antecedentes quirúrgicos: Artroplastía rodilla izquierda y derecha

Fármacos: No

Alergias: No conocidas

Inmunización: COVID-19 (2 dosis Sinovac, 1 dosis Astrazeneca)

Hospitalizaciones: (-)

Contacto: Priscilla Cid Espinoza (hija), 9-50243227

Motivo de ingreso: Disnea

Anamnesis próxima:

Paciente previamente sano, consulta el 03/03 en Servicio de Urgencias por cuadro progresivo de 8 días de evolución de astenia, tos y disnea, hasta hacerse de reposo.

Al ingreso al Servicio de Urgencias se constata taquicárdico (FC 130 lpm), hipertenso (PA 160/88 mm), afebril (T° 37.3°C), saturando 76% ambiental. Al examen físico destaca mala mecánica ventilatoria y crépitos difusos bilaterales.

Dentro de los exámenes de ingreso destaca leucocitosis (GB 12410), PCR 356 y PCR SARS COV2 (+). Se realiza AngioTAC de Tórax que muestra extensas opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales y subpleurales, de predominio condensante, que comprometen todos los lóbulos pulmonares.

Evoluciona en malas condiciones generales con altos requerimientos de oxígeno y progresión de disnea, requiriendo VMI. Se

Fecha Epicrisis : 29/04/2022 10:47

Página 1 de 5

traslada a UPC para continuar manejo.

Diagnósticos de ingreso:

- 1.-Insuficiencia respiratoria aguda
- 2.-Neumonía COVID 19 grave

Evolución por planes y problemas durante hospitalización (UPC - UTIM - UPC - UTIM-SALA):

Hemodinamia: Durante estadía en UPC se mantuvo sin DVA, con tendencia a la hipertensión y mala distribución de VEC con requerimiento de hemodiálisis de forma intermitente en relación a uremia. Durante estadía en UTIM evoluciona estable sin DVA, aunque febril y con taquicardia sinusal persistente (en contexto de fiebre). Se mantuvo monitorización invasiva. Durante el reingreso a UPC se mantuvo estable sin DVA, con disminución de taquicardia sinusal. Requiere Tx 1 UGR, sin exteriorización de sangrado. En sala evoluciona estable, normotenso con tendencia a la taquicardia, con VEC normal. Se mantuvo sin necesidad de vasodilatadores orales y con monitorización no invasiva. Actualmente bien perfundido, sin conflictos.

Respiratorio: Ingresó por SDRA por neumonía grave COVID-19, requirió VMI desde el 03/03 que se prolongó en relación a neumonía organizada secundaria manejada con pulso de Metilprednisolona 375 mg + dosis diaria de Prednisona 1 mg/kg con decalaje progresivo de dosis y Cotrimoxazol forte profiláctico, que los completa el 21/04. Por compromiso de conciencia se decidió TQT percutánea 8 (25/03) con persistencia de requerimiento de conexión a VMI hasta el 03/04, logrando disminuir requerimientos hasta 3 L/min de oxígeno por TQT, logrando tolerancia a cuff desinflado por 1 h, por lo que se decide traslado a UTIM para continuar rehabilitación y entrenamiento respiratorio. En dicha unidad presenta fracaso al destete, por lo que se traslada nuevamente a UPC para consolidar weaning. Al reingreso a UPC se continuó rehabilitación y entrenamiento respiratorio, consolidando weaning. Se traslada nuevamente a UTIM donde logra suspensión de suplementación de oxígeno. Posteriormente, paciente evoluciona favorablemente en cuanto a lo respiratorio, sin mal manejo de secreciones, por lo que se decanula el 22/04, sin incidentes. Actualmente, sin requerimientos de O2, no es conflicto.

Infeccioso: Ingresó por neumonía COVID-19 grave, con inicio de síntomas el 24/03 y PCR SARS COV2 (+) 03/03, con AngioTC de tórax del 03/03 que evidencia neumopatía multifocal por COVID-19, completó 7 días de Dexametasona. Evoluciona con múltiples interurrencias infecciosas durante estadía hospitalaria:

PNA bacteriémica por E coli (S) Amika-Cefotaxima-Tazonam, (R) a Ampicilina-Sulbactam (UC y HC 04/03) inició Ampicilina-Sulbactam completando 4 días, luego se rotó a Ceftriaxona completando 4 días y luego a Imipenem por nueva interurrencia infecciosa.

NAVM por K. pneumoniae BLEE (CST film array 10/03) completando 8 días de Imipenem y 3 días de vancomicina.

Aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19 (GMN 11/03 5.4, AngioTC 17-03 con persistencia de opacidades pulmonares), recibiendo Voriconazol en dosis terapéuticas por 13 días.

Traqueitis por E coli (R) Ciprofloxacino y Cotrimoxazol y KPN MS, tratada con Imipenem por 10 días.

Posteriormente se traslada a UTIM en donde se mantiene febril durante toda la estadía. Se cultivó y se mantuvo Imipenem, Vancomicina y Voriconazol (de este último se ajusta a dosis de mantención 4 mg/kg c/12h). Del nuevo estudio:

Bacteriemia por S. haemolyticus 100 UFC/ml (05/04 arrastre de catéter 1era muestra(-), 2da muestra(+)), tratada con vancomicina por 14 días.

ITU con UC (+) C. albicans 100.000 UFC, tratada con Voriconazol por 7 días.

05/04: TAC TAP: fenómenos organizativos y menor extensión de neumopatía. Signos de trombosis venosa parcial femoral derecha e ilíaca izquierda en relación al catéter venoso, con gas en trombo derecho, pudiendo reflejar sobreinfección. Se retiró el catéter, cultivo punta (-).

Durante reingreso a UPC presenta múltiples peak subfebriles, de cultivos tomados en esta unidad no se aíslan microorganismos con rol patógeno (HC y Film Array el

10/04 que muestra S. epidermidis MR). Se continúa con Vancomicina ajustada según función renal, completando 14 días dado cultivo con S.haemolyticus en sangre y Voriconazol por 7 días dado C. albicans en UC. El 24/04, presenta nuevo peak febril por lo que se pancultiva,destacando SO inflamatorio y E.coli R AMS, por lo que se deja empíricamente imipenem + linezolid, por antecedente de portación por E. Faecium Van B, posteriormente se ajusta terapia según cultivos y se deja ceftriaxona, para completar 7 días, hasta el domingo 01/05, incluido. . Actualmente, se ha mantenido afebril por más de 72 horas, con PPII a la baja.

Nefrológico: Sin antecedente de ERC, con Creatinina al ingreso 0.97, presenta quiebre en función renal en 24 h (creatinina 1-4), asociado a hiperkalemia, acidosis metabólica, con diuresis conservada. Inició hemodiálisis el 07/03 con requerimientos intermitentes, logrando suspensión (última HD 04/04). Evolucionó con mejoría sostenida en diuresis y función renal, por lo que se retira CVC. Respecto al estudio de falla renal, se realiza TAC (05/04) que evidencia riñones, uréteres y vejiga sin

Fecha Última Actualización: 29-04-2022 10:47:38

Página 3 de 5

alteraciones salvo quistes de aspecto simple en ambos riñones y prostatomegalia, con APE 1.72, SO activos pero tomados en contexto de infección, IPC 8.7, RAC 3900, C3/ C4 normal, ANA y ANCA negativos, serologías virales (VIH, VHB, VHC) no reactivas. Ingresa a sala con crea 1.6, por sepsis x ITU CUP sufre AKI pre renal KDGO II, que responde adecuadamente a volemización. Actualmente, Última crea del 28/04 en 1.62. Al alta control con neurología en un mes, para evaluar función renal, y antecedentes de proteinuria durante hospitalización.

Urológico: Durante su estadía hospitalaria presentó hematuria leve persistente durante primera estadía en UPC, manejada con irrigación vesical y resolución espontánea, sin nuevos episodios de hematuria posteriormente. Dado prostatomegalia, se mantiene sonda foley, se solicita eco vesico prostática, pero pendiente durante hospitalización. Al alta control con urología para definir mantención de sonda foley por antecedente de prostatomegalia.

Endocrinológico: Uso prolongado de corticoides a altas dosis en contexto de SDRA por neumonía grave COVID-19, con decalaje completado el 21/04.

Neurológico: Durante estadía en UPC sin episodios de agitación pero con requerimiento intermitente de Dexmedetomidina. Posteriormente evoluciona consciente, sin presencia de agitación psicomotora o cuadro sugerente de delirium, por lo que se opta por manejo ambiental, favoreciendo retiro de dispositivos. Actualmente vigil, tranquilo, sin necesidad de antipsicóticos.

Rehabilitación :

KNT: Paciente con miopatía de paciente crítico, en rehabilitación respiratoria y motora por kinesioterapia. Actualmente logra sentarse en sillón por períodos acotados dado dolor en zona sacra por LPP, se deja analgesia pre kine. Impresiona fuerza M3 -4 en extremidades, predominio de miopatía a nivel proximal. LPP sacra grado II en curación c/48 hrs por equipo de enfermería, cambio de posición cada 4 hrs, prohibido posición decúbito supino

FNA: Disfagia severa recuperada por lo que se retira TQT y SNG. Con buena tolerancia a régimen blando sin granos + líquidos claros. Re-valorado por equipo, quienes le dan el alta por especialidad, ya que presenta buena tolerancia oral, sin trastorno de deglución.

Profilaxis/ETE: Por hematuria persistente se mantiene sin tromboprofilaxis hasta el 10/04, cuando se inicia HNF. En TC del 05/04 se pesquisa trombo ocluyendo parcialmente las venas femoral común y superficial derechas, con algunas burbujas en su espesor, en relación a CVC (actualmente retirado), por lo que se tras resolución de hematuria se decide inicio de anticoagulación. El 22/04 se re controla con eco doppler y se observa TVP parcial de territorio ilíaco externo, femoral común y femoral derecha + TVP parcial de territorio ilíaco externo, femoral común, femoral y poplíteo izquierdo, por lo que se mantiene anticoagulación con HBPM. Pendiente iniciar traslape por hospitalización domiciliaria, con miras de completar 3 meses de anticoagulación pro evento provocado, que los completa el 05/07.

Diagnósticos de egreso

1) Insuficiencia respiratoria aguda con weaning consolidado

- NAC COVID-19 recuperado
- FIS 24/02, PCR (+) 03/03, día 44
- Neumonía organizada secundaria resuelta
- VMI 30 días- Prono 6 días
- TQT percutánea 25/03 8
- Weaning VMI 13/04
- Decanulación 22/04

2) Polineuropatía paciente crítico

- LPP sacra grado II en curaciones
- Disfagia severa FLS 3 resuelta

3) AKI KDIGO III en resolución

- TRR entre 07/03 - 04/04

4) TVP proximal bilateral en tratamiento

Resueltos

- PNA bacterémica por E coli
- NAVM por KPN BLEE
- Aspergilosis pulmonar (GMN positivo en LBA) - 13 días voriconazol

Fecha Epicrisis : 29/04/2022 10:47

Página 3 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:45

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 29-04-2022 10:47:38

Página 4 de 5

- Traqueobronquitis por E coli + KPN MS - 10 días imipenem
- Bacteremia por Staphylococcus coagulasa negativo - 14 días vancomicina
Antecedentes: Gonartrosis bilateral operada, Inmunizado 3 dosis.

Condición al alta:

Paciente estable en mejores condiciones generales, con hemodinamia estable normotensa, normocardico sin requerimientos de O2, afebril hace más de 72 hrs. Buena tolerancia de ayer, sin náuseas ni vómitos.

Actualmente en tratamiento con ceftriaxona por ITU CUP x E coli R AMS/ Cipro en tratamiento.

Diuresis ++ cc Depo (++)

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda - Covid - Capa
Insuficiencia Renal Aguda -
Sepsis, no especificada -
Trombosis Venosa profunda -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Condición al alta:

Paciente estable en mejores condiciones generales, con hemodinamia estable normotensa, normocardico sin requerimientos de O2, afebril hace más de 72 hrs. Buena tolerancia de ayer, sin náuseas ni vómitos.

Actualmente en tratamiento con ceftriaxona por ITU CUP x E coli R AMS/ Cipro en tratamiento.

Diuresis ++ cc Depo (++)

Plan Post Alta

INDICACIONES PARA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA

1.-Reposo relativo, decúbito lateral estricto. No puede estar en supino. Cambio de posición frecuente ojala cada c/4 hrs. Activar por kinesiología.

2.-Régimen blando, sin granos + líquidos claros. Progresar segun evolucion. Asistido y pausado. Suplemento alimenticio 2 veces al día.

3.- Kinesioterapia respiratoria y motora + Analgesia pre kinesiología

4.- Mantener Sonda foley

5.-Iniciar traslape de anticoagulación.

Medicamentos:

1)Ceftriaxona 2 gr cada 24 horas endovenoso hasta el domingo 01/05 incluido

2)Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 8 hrs vía oral por 30 días

3)Metoclopramida 10mg cada 8 horas vía oral en caso de náuseas por 30 días

4)Bromuro de ipatropio 4 puff cada 4 h por aerocámara para 30 días.

5) Pregabalina 75 mg, 1 comprimido cada 24h Vía oral por 30 días (se hace receta)

6) PEG 15 g en 200 cc de agua cada 12 hrs vía oral por 30 días. Titular para 1-2 deposiciones blandas diarias.

7) Tramadol 100 mg/ml en gotas, dar 12 gotas cada 8 horas por 1 mes vía oral , en relación a terapia kinesiológica por 30 días. Familia lo comprara.

8)Enoxaparina 80 mg cada 12 h SC por el momento hasta iniciar traslape con TACO

En resumen para hospitalización domiciliaria.

1.-Kinesiología respiratoria y motora diaria los primeros 3 a 4 semanas, y luego evaluar según rehabilitación

2.-Curaciones de lesión por presión grado II cada 48 horas.

3.-Completar tratamiento ATB con ceftriaxona una vez al día , hasta el 01/05.

4.-Iniciar traslape de anticoagulación hasta completar 3 meses (05/07)

5.-Cuidados de sonda foley hasta control con urología.

Fecha Epicrisis : 29/04/2022 10:47

Página 4 de 5

Fecha Última Actualización: 29-04-2022 10:47:38

Página 5 de 5

Tomar: Clearence de creatinina en 2 semanas mas

Controles (Solicitar con este documento "Epicrisis") :

- 1.-Evaluación por broncopulmonar en diferido con pruebas de función pulmonar para evaluar secuelas post SDRA por NAC Covid
 - 2.-Evaluación por urología para evaluar prostatomegalia y retiro de sonda foley
 - 3.- Continuar en seguimiento con Poli de TACO
 - 4.-Controles con fisiatria en forma ambulatoria. solicitar hora con este documento.
- Acudir al Servicio de Urgencias: Si fiebre $>38^{\circ}\text{C}$ que no cede a analgesia, dolor torácico, dificultad para respirar, vómitos con sangre, mayor compromiso de conciencia o en caso que usted lo estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Blando Sin Granos Mas Líquidos Claros

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Alberto Sarratis Feige
Médico Tratante (Staff)